

Check-in | Dienstag 14.07.2026

R = Readiness 1-5. MK = Muskelkater 0-10. A = Ampel G/Y/R. Cluster: CF / HY / SB. Einziger deutlicher Hauptregler heute: Kraftintensitaet. Vorab rollierend ab ca. 18:50 beginnen.
Kopf/Nacken/Schwindel/neurologisch/Concussion-Verdacht = sofort raus, medizinisch abklaeren, keine Rueckkehr am selben Tag. Gelb: Speed/Volumen 30-50 % runter, Kraft 2 Saetze @ RPE 5-6, kein HY-Reaccel, kein Conditioning.

Nr	Name	Pos/Cl.	R	MK	Schmerz + Ort	09.07-Reaktion / Life Load	Ret/Limit	A	Entscheidung heute
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Grueue ohne Aenderung nicht einzeln interviewen. Code: normal | Speed red. | kein Reaccel | Kraft 2x4 | kein Cond. | Returner-Cap | klaeren.

Beobachtung + Nachbereitung | Dienstag 14.07.2026

Hauptlift immer dokumentieren. Sonst nur Auffaelligkeiten, Regressionen und reale Dosis eintragen. Direkt pro Spieler nur sRPE und Pain/Issue. Dauer einmal; KI, Conditioning und reale Dosis danach aus Coach-Entscheidungen ergaenzen.
Kuerzen: optionales Conditioning, Cluster verkuerzen, Power reduzieren; Kraft lieber zwei saubere Saetze. Ab 15 Spielern Pod B/C je 2 Saetze; Pod A 3x4 nur bei sauberem Lane-Durchlauf.

Beobachtung pro Spieler

Nr	Name	Speed gemacht	Jump/MB	Hauptlift Last	Saetze/Reps/RPE	Cluster	Cond.	sRPE direkt	Pain/Do-Schritt
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Coach-Review: Anwesend __ | G/Y/R __/__/__ | CF/HY/SB __/__/__ | 3x4 @ RPE7 __ | Kraft reduziert __ | Cluster reduziert __ | KI 0/1 __/__ | Cond. 0/1 __ | sRPE Bereich __ | neue Pain/Issue __ | Donnerstag reduzieren/Ruecksprache: _____